

Alopecia areata y alopecia androgenética

(Basado en Guías Clínicas MINSAL Chile 2023, British Association of Dermatologists 2024, American Academy of Dermatology 2024, EADV Guidelines 2024, UpToDate 2025 y Fitzpatrick's Dermatology 2023.)

1. Introducción y relevancia clínica

La **alopecia** es la **pérdida anormal o ausencia de cabello**, parcial o total, que puede tener **causas autoinmunes, hormonales, hereditarias o secundarias** a otras patologías.

Las dos formas más comunes en la práctica clínica son:

- **Alopecia areata (AA):** autoinmune, no cicatricial, de curso impredecible.
- **Alopecia androgenética (AGA):** hereditaria y dependiente de andrógenos, la más frecuente en ambos sexos.

Relevancia clínica

- Ambas son **de alta prevalencia** y **frecuente motivo de consulta dermatológica y emocional**.
 - En **EUNACOM**, se evalúa su **patogenia, patrón clínico, diagnóstico diferencial y tratamiento según severidad**.
 - Son entidades **no cicatriciales**, es decir, **reversibles si se tratan a tiempo**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Alopecia Areata (AA)

Mecanismo patogénico

- Es una **enfermedad autoinmune órgano-específica** que afecta el **folículo piloso anágeno**.
- Los linfocitos T CD8+ atacan los folículos en crecimiento, interrumpiendo el ciclo piloso y produciendo caída súbita.

- Se preservan las células madre del bulbo, lo que explica la **reversibilidad del proceso**.

Factores asociados

- Predisposición genética (asociación con HLA-DR4, HLA-DQ3).
 - Comorbilidades autoinmunes: tiroiditis de Hashimoto, vitiligo, lupus, diabetes tipo 1, anemia perniciosa.
 - Factores emocionales: estrés agudo, ansiedad, trauma psicológico.
-

2.2. Alopecia Androgenética (AGA)

Mecanismo patogénico

- Proceso **genético y hormonal dependiente de andrógenos**, especialmente **dihidrotestosterona (DHT)**.
- La DHT, formada por acción de la **5-alfa reductasa tipo II**, induce **miniaturización progresiva de los folículos** y acortamiento de la fase anágena.
- Los cabellos terminales se transforman en vellos finos y cortos (*vellus*).
- Los folículos permanecen viables → la alopecia **no es cicatricial ni irreversible**.

Factores determinantes

- Herencia poligénica (patrón familiar).
 - Niveles normales de andrógenos, pero con **mayor sensibilidad folicular**.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Alopecia Areata

Presentación típica

- **Pérdida súbita y circunscrita del cabello**, sin inflamación ni cicatriz.

- Placas **redondeadas u ovals**, con piel lisa y brillante.
- En los bordes, pelos cortos en forma de “**signo de exclamación**” (afinados en la base).
- Puede afectar cuero cabelludo, cejas, pestañas, barba o vello corporal.

Formas clínicas

Tipo	Descripción
Alopecia areata localizada	Una o pocas placas circunscritas
Alopecia total	Pérdida completa del cabello en cuero cabelludo
Alopecia universal	Pérdida total de todo el vello corporal
Alopecia ofiásica	Afecta periferia del cuero cabelludo (occipital y temporal)
Difusa	Pérdida generalizada sin áreas delimitadas

Signos acompañantes

- **Uñas:** puntilleo (pitting), fragilidad, estriación.
- En casos severos, alteraciones emocionales (ansiedad, depresión).

3.2. Alopecia Androgenética

Presentación típica

- Pérdida **gradual y progresiva del cabello** en zonas de patrón androgénico.
- No hay inflamación ni cicatriz.

- Cabellos finos y miniaturizados.

Patrón en hombres (Hamilton–Norwood):

- Recesión bitemporal → calvicie frontal → coronilla → fusión central.
- Etapas I a VII según extensión.

Patrón en mujeres (Ludwig):

- Adelgazamiento difuso de la región parietal central, con preservación de la línea frontal.
- Clasificación I (leve) a III (severa).

Signos acompañantes

- En mujeres, puede coexistir con **hirsutismo, acné o irregularidad menstrual** → descartar hiperandrogenismo.

3.3. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Efluvio telógeno	Caída difusa y reversible 2–3 meses tras estrés o fiebre
Tiña capitis	Placas con descamación, prurito, pelos rotos, KOH positivo
Lupus discoide	Placas eritematosas atróficas con descamación periférica
Liquen plano pilar	Cicatriz con pápulas periféricas y prurito
Tricotilomanía	Parches irregulares, pelos de distintas longitudes

Sífilis secundaria “Alopecia en parches de polilla”, VDRL positivo

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Alopecia areata

Diagnóstico clínico, pero pueden solicitarse:

- **Tricoscopia (dermatoscopia capilar):**
 - Pelos en signo de exclamación.
 - Puntos amarillos (folículos vacíos).
 - Puntos negros (pelos rotos).
 - **Biopsia capilar:** si diagnóstico incierto o sospecha de alopecia cicatricial.
 - Infiltrado linfocitario peribulbar (“enjambre de abejas”).
 - **Estudio tiroideo y autoinmune:** TSH, anticuerpos antitiroideos, ANA si múltiples enfermedades autoinmunes.
-

4.2. Alopecia androgenética

Diagnóstico clínico con apoyo de:

- **Tricoscopia:**
 - Variabilidad del diámetro >20%.
 - Folículos vacíos y miniaturizados.
- **Perfil hormonal en mujeres:**
 - Testosterona total y libre, DHEA-S, LH/FSH, prolactina, TSH.
- **Biopsia (rara vez necesaria):** miniaturización folicular sin inflamación.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / AAD / EADV)

5.1. Alopecia areata

Severidad	Tratamiento	Comentarios
Leve (placas pequeñas)	Corticoides intralesionales (Triamcinolona 2.5–10 mg/mL) cada 4–6 sem	Primera elección; respuesta 60–80%
Extensa o difusa	Corticoides sistémicos (prednisona 0.5–1 mg/kg/día por 4–6 sem) o pulsos	Controlar efectos adversos
Tópicos	Clobetasol 0.05%, minoxidil 5%, antralina o irritantes tópicos (ditranol)	En combinación
Inmunoterapia tópica (difusa / resistente)	Difenilciclopropenona (DPCP) o ácido squárico	Induce dermatitis de contacto controlada
Nuevos tratamientos (2024)	Inhibidores JAK (baricitinib, tofacitinib) con resultados prometedores	En casos refractarios o extensos
Apoyo psicológico	Fundamental por impacto emocional	Consejería o terapia cognitiva

5.2. Alopecia androgenética

[illegible]

Hombres (leve a moderada)	Minoxidil 5% tópico	Aplicar 1 mL 2 veces/día, respuesta a 4–6 meses
	Finasterida 1 mg oral/día	Inhibe 5 α -reductasa tipo II; frena progresión
Mujeres	Minoxidil 2–5% tópico	Tratamiento base
	Finasterida o dutasterida (solo postmenopáusicas)	Requiere anticoncepción si edad fértil
	Espironolactona 100–200 mg/día	Antagonista androgénico útil si hay hiperandrogenismo
Opcional	Plasma rico en plaquetas (PRP) o microneedling	Complementario en AGA leve
Trasplante capilar	En casos estables y refractarios	Solo cuando no hay inflamación activa

El tratamiento es crónico y debe mantenerse indefinidamente para conservar los resultados.

La suspensión de finasterida o minoxidil → pérdida de los folículos recuperados en 3–6 meses.

5.3. Educación y medidas generales

- Evitar peinados traccionantes, calor excesivo o químicos agresivos.
 - Alimentación equilibrada rica en zinc, hierro y proteínas.
 - Control de enfermedades asociadas (tiroides, anemia, estrés).
 - Fotoprotección del cuero cabelludo descubierto.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Tipo	Alopecia Areata	Alopecia Androgenética
Recurrencia	Frecuente (30–50%), incluso tras remisión completa	Inevitable si se suspende tratamiento
Secuelas estéticas	Impacto emocional importante	Crónica, lentamente progresiva
Asociaciones sistémicas	Tiroiditis, vitiligo, lupus, diabetes tipo 1	Síndrome metabólico, hiperandrogenismo femenino
Pronóstico	Variable; mejor si localizada y de inicio adulto	Estable pero progresiva; tratable, no curable

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Alopecia areata:** autoinmune, placas redondas sin cicatriz, pelos en signo de exclamación.
2. **Alopecia androgenética:** patrón característico por miniaturización progresiva dependiente de DHT.
3. En AA, el tratamiento de elección son los **corticoides intralesionales**.
4. En AGA masculina, **finasterida 1 mg/día + minoxidil 5%** son el manejo estándar.
5. En mujeres premenopáusicas, preferir **espironolactona o minoxidil tópico**.
6. **Nunca usar finasterida en mujeres fértiles sin anticoncepción eficaz.**

7. Ambas son **no cicatriciales**, es decir, **reversibles con tratamiento precoz**.
-



Errores comunes

- Diagnosticar alopecia areata sin buscar enfermedades autoinmunes asociadas.
 - Indicar corticoides sistémicos prolongados en AA leve.
 - Esperar “curación” con finasterida o minoxidil → ambos requieren uso continuo.
 - Confundir AGA con efluvio telógeno o tiña capitis.
 - No advertir sobre efectos adversos sexuales de finasterida (libido, disfunción eréctil).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **alopecia areata** es una **enfermedad autoinmune** que produce **placas circunscritas de caída de cabello sin cicatriz**, con pronóstico variable.
2. La **alopecia androgenética** es **hereditaria y dependiente de DHT**, con patrón característico y progresivo.
3. Ambas son **no cicatriciales y potencialmente reversibles** si se tratan precozmente.
4. En **AA localizada**, el tratamiento de elección son **corticoides intralesionales**; en difusa o severa, corticoides sistémicos o inhibidores JAK.
5. En **AGA masculina**, **minoxidil tópico + finasterida oral** es el estándar de oro; en mujeres, **minoxidil ± espironolactona**.
6. **Tricoscopía y evaluación hormonal o autoinmune** orientan el diagnóstico diferencial.
7. En **EUNACOM**, la pista clave:
 - “Placa redonda sin descamación ni cicatriz” → *Alopecia areata*.

- “Recesión bitemporal progresiva” → *Alopecia androgenética*.